

Urétrographie rétrograde (RUG)

WARWIKI

Information pour le patient · Ce que vous devez savoir avant votre radiographie de l'urètre

L'urétrographie rétrograde — ou « RUG » — est un examen radiologique rapide qui prend des images de votre urètre, le canal qui évacue l'urine hors de votre corps. Une petite quantité de produit de contraste est introduite doucement dans l'urètre pour le rendre visible à la radiographie. Cela permet à votre chirurgien de localiser et de mesurer tout rétrécissement, toute cicatrice ou toute lésion avant de planifier votre traitement.

À propos de cet examen

Le tissu cicatriciel ou un rétrécissement de l'urètre — appelé **rétrécissement de l'urètre** — peut être difficile à voir sur une radiographie classique. La RUG remplit le canal avec un produit de contraste qui apparaît en blanc sur la radiographie, créant ainsi une « carte » précise de l'intérieur de votre urètre.

Votre chirurgien peut prescrire une RUG pour :

- Repérer un rétrécissement ou une cicatrice et en mesurer l'emplacement et la longueur
- Évaluer l'urètre après une blessure
- Planifier une chirurgie de réparation de l'urètre
- Vérifier la cicatrisation de l'urètre après une réparation

L'examen montre le canal ouvert à l'intérieur de votre urètre — le trajet que suit l'urine. Il ne visualise pas les reins et n'est pas un traitement ; c'est une image qui guide la suite de votre prise en charge.

Est-ce sans danger ?

Oui. La RUG est un examen courant et peu risqué. La dose de rayons X est faible, et le produit de contraste est à base d'eau ; il est éliminé dans votre urine. La plupart des patients ne ressentent qu'une légère gêne passagère. Les effets indésirables rares — infection urinaire, léger saignement ou gêne à la miction — sont généralement bénins et disparaissent rapidement.

COMPRENDRE LES TERMES

Urètre

Le canal qui transporte l'urine de la vessie vers l'extérieur du corps.

Rétrécissement de l'urètre

Un passage étroit ou cicatriciel dans l'urètre pouvant ralentir ou bloquer le flux urinaire.

Produit de contraste

Un liquide qui apparaît en blanc sur la radiographie, permettant de visualiser l'intérieur de l'urètre.

Sonde

Un tube fin et souple. Pour cet examen, seule l'extrémité est introduite à l'entrée de l'urètre — elle ne va pas plus loin.

Fluoroscopie

Un type de radiographie qui montre des images en temps réel pendant que le produit de contraste s'écoule.

Méat urétral

L'orifice à l'extrémité du pénis par lequel l'urine sort.

Examen cytot bactériologique des urines (ECBU)

Un test sur un échantillon d'urine pour vérifier l'absence d'infection avant l'examen.

Urologue reconstructeur

Un chirurgien spécialisé dans les voies urinaires et la réparation de l'urètre.

EST-CE QUE ÇA FAIT MAL ? La plupart des patients ne ressentent qu'une légère pression ou un léger picotement lors de l'introduction du produit de contraste, sans douleur vive. L'équipe peut ralentir à tout moment — signalez-le si vous êtes gêné. L'examen dure environ 15–30 minutes.

Comment vous préparer (Avant l'examen)

La préparation est très simple. Dans la plupart des cas :

- Vous pouvez **manger et boire normalement** — pas de jeûne nécessaire, sauf indication contraire de votre équipe.
- Prenez vos **médicaments habituels**, sauf si votre équipe vous demande d'en arrêter un.
- Vous pouvez généralement **rentrez seul chez vous**, car la plupart des patients n'ont pas besoin de sédation.

Informez votre équipe à l'avance si vous :

- Avez déjà eu une réaction au produit de contraste ou à l'iode
- Prenez un anticoagulant
- Présentez des signes d'infection urinaire (brûlures, fièvre, ou urines troubles à odeur forte) — une infection active peut entraîner le report de l'examen

On pourra vous demander un **échantillon d'urine** pour dépister une infection, et un **antibiotique** pourra vous être prescrit avant ou après l'examen pour réduire le faible risque infectieux.

Déroulement de l'examen

- 1 Vous vous allongez sur la table de radiologie, généralement légèrement de côté. L'équipe vous aide à trouver la bonne position.
- 2 L'extrémité du pénis est nettoyée. Une petite sonde souple est placée **juste à l'entrée** de l'urètre — seulement le bout. Un petit ballonnet peut être légèrement gonflé pour la maintenir en place.
- 3 Le produit de contraste est introduit lentement dans l'urètre pendant que les radiographies sont prises. On peut vous demander de rester immobile et de respirer normalement.
- 4 L'équipe observe le produit de contraste sur un écran et prend quelques clichés sous différents angles. La sonde est ensuite retirée.

Après l'examen

- Vous pouvez généralement rentrer chez vous et reprendre vos **activités normales immédiatement**.
- Vous pouvez ressentir de **légères brûlures à la miction** pendant un jour environ. Boire plus d'eau aide à éliminer le produit et soulage cet inconfort.
- Vous pouvez noter **un peu de sang** à l'extrémité du pénis ou une légère teinte rosée dans vos urines. C'est courant et cela disparaît généralement en un jour.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- De la fièvre ou des frissons
- Des difficultés à uriner ou une impossibilité totale d'uriner
- Un saignement abondant ou qui ne s'arrête pas
- Une douleur qui s'aggrave au lieu de diminuer

TROIS CHOSES À RETENIR

1. La RUG est un examen radiologique qui cartographie l'intérieur de votre urètre grâce à un produit de contraste — pour aider votre chirurgien à planifier le traitement.
2. La préparation est minime : mangez et prenez vos médicaments normalement, mais signalez toute allergie au contraste, anticoagulant ou signe d'infection urinaire.
3. La plupart des patients ne ressentent qu'une légère pression et rentrent aussitôt. De légères brûlures ou un peu de sang pendant un jour sont normaux — buvez davantage d'eau.